



สถานะสุขภาพ ประชาชน ปีงบประมาณ 2568

ศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านกล้วยแพะ

สังกัดเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จังหวัดลำปาง



สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป

1-2

ลักษณะองค์กร

3-9

สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ

10-14

ข้อมูลทั่วไป



ที่ตั้งอาณาเขต:

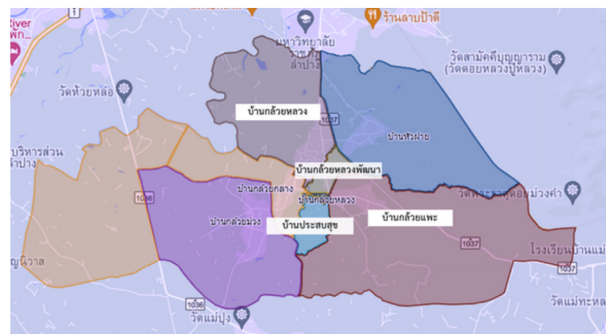
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประมาณ 46.06 ตร.กม. อยู่ห่างจากอำเภอเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลพระบาท

ทิศตะวันออก ติดกับบ้านกล้วยฝาย

ทิศตะวันตก ติดกับบ้านกล้วยม่วง

ทิศใต้ ติดกับอำเภอแม่ทะ



รูปภาพ 1 แผนที่ตำบลกล้วยแพะ และเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศบส.บ้านกล้วยแพะ

ลักษณะภูมิศาสตร์:

เป็นที่ราบสลับเนิน เป็นพื้นที่ป่ามีพื้นที่ราบลุ่มสำหรับการเกษตร และมีลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท

การปกครอง:

เขตรับผิดชอบทั้งหมด 2 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ชุมชนบ้านกล้วยแพะ และชุมชนบ้านประสพสุข

ข้อมูลทั่วไป



สภาพทางเศรษฐกิจ:

มีสภาพเศรษฐกิจที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน และรับจ้างมัดหอมและกระเทียม มีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ได้แก่ โรงงานเซรามิก โรงงานถั่วลิสง และมีวัยแรงงานที่ไปทำงานนอกพื้นที่ เช่น รับจ้างในตัวเมือง และต่างจังหวัด

บริบทชุมชน:

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ มีการใช้ภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ และภาษาไทยในการสื่อสาร มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเอง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ มีประเพณีไทยลื้อที่สืบทอดกันมาช้านาน เช่น ประเพณีไหว้ผีพื้นบ้าน ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีสลากภัตร ประเพณีข้าวจีข้าวหลาม ประเพณีเย็บลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์พระธาตุ เป็นต้น

ด้านสาธารณสุข:

ตำบลกล้วยแพะมีสถานบริการสุขภาพและเครือข่าย ประกอบด้วย

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ 1 แห่ง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง 1 แห่ง
3. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 221 คน



รูปภาพ 2 แสดงอาชีพการรับจ้างมัดหอมและกระเทียม



รูปภาพ 3 แสดงการแต่งกายของชาวไทยลื้อ

ลักษณะองค์กร



ประวัติ :

ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ เดิมเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยแพะ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณสุขให้ท้องถิ่นดูแล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีอาคารราชพัสดุ 2 ชั้น สร้างในปีงบประมาณ 2533 งบประมาณ 318,900 บาท

ข้อมูลการนำองค์กร :

- วิสัยทัศน์ บริการได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
- พันธกิจ
1. พัฒนาสถานบริการ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
 3. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนในพื้นที่

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3. ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ค่านิยม ซื่อสัตย์มีวินัย มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม

ข้อมูลประชากร :

ตาราง 1 ข้อมูลประชากรจำแนกรายหมู่บ้านเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2568 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร (คน)		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	กล้วยหลวง	2,526	2,579	2,567
2	กล้วยแพะ	2,039	2,076	2,026
รวม		4,565	4,655	4,593

ที่มา: รายงานจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร จาก HDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568

จากตาราง 1 แสดงข้อมูลประชากรจำแนกรายหมู่บ้านเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2566 - 2568 พบว่าจำนวนประชากรรวมมีแนวโน้มคงที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2566 มีจำนวนประชากร 4,565 คน ส่วนในปี 2568 มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 4,655 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.61 แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของจำนวนประชากรในพื้นที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านในปี 2568 พบว่าประชากรหมู่ที่ 1 บ้านกล้วยหลวง มีจำนวนมากที่สุด 2,567 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วยแพะ จำนวน 2,026 คน

ลักษณะองค์กร



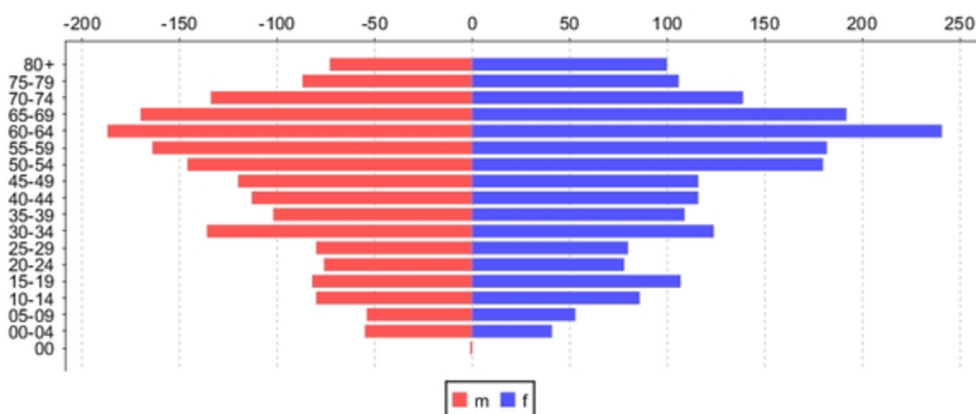
ตาราง 2 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบเป้าหมายประชากรสำรวจ ปี 2568

กลุ่มอายุ	เป้าหมายประชากร					
	ประชากรรวม		ชาย		หญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แรกเกิด-04	97	2.47	55	1.40	42	1.07
05-09	109	2.78	56	1.43	53	1.35
10-14	173	4.41	84	2.14	89	2.27
15-19	190	4.85	82	2.09	108	2.75
20-24	143	3.65	69	1.76	74	1.89
25-29	168	4.28	85	2.17	83	2.12
30-34	258	6.58	135	3.44	123	3.14
35-39	210	5.36	102	2.60	108	2.75
40-44	229	5.84	112	2.86	117	2.98
45-49	240	6.12	122	3.11	118	3.01
50-54	325	8.29	145	3.70	180	4.59
55-59	355	9.05	167	4.26	188	4.79
60-64	425	10.84	185	4.72	240	6.12
65-69	353	9.00	169	4.31	184	4.69
70-74	273	6.96	134	3.42	139	3.55
75-79	194	4.95	88	2.24	106	2.70
มากกว่า 80	179	4.57	74	1.89	105	2.68
รวม	3921	100.00	1,864	47.54	2,057	52.46

ที่มา: รายงานประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2568 (Type 1+3) จาก JHCIS ณ วันที่ 15 ต.ค. 68

จากตาราง 7 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุจำแนกเพศ ซึ่งประชากรสำรวจอยู่อาศัยจริง ปี 2568 จากข้อมูลประชากรรวมทั้งสิ้น 3,921 คน พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.46 โครงสร้างประชากรส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.02 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.32 ในขณะที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีเพียงร้อยละ 9.66 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่งผลให้การวางแผนด้านสาธารณสุขควรมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการป้องกันโรคเรื้อรังในวัยแรงงานเป็นสำคัญ

ลักษณะองค์กร



รูปภาพ 4 แสดงปิรามิดประชากร ข้อมูลจาก JHCIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568

จากรูปภาพ 4 แสดงปิรามิดประชากร พบว่าโครงสร้างประชากรของพื้นที่มีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมฐานแคบ โดยกลุ่มช่วงอายุ 60-64 ปี เป็นช่วงอายุที่กลุ่มใหญ่ที่สุด สะท้อนถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ในขณะที่จำนวนเด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 14 ปี มีจำนวนแนวโน้มที่ลดลง แสดงถึงอัตราการเกิดที่ลดลงและแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านทางประชากรอย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดสรรทรัพยากรบุคคลากรให้เหมาะสมกับโครงสร้างประชากรของพื้นที่

ตาราง 3 แสดงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ ปี 2568

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด	1438 หลัง	ผู้สูงอายุติดสังคม	1387 คน
ประชากรสำรวจ	3921 คน	ผู้สูงอายุติดบ้าน	29 คน
ชาย	1864 คน	ผู้สูงอายุติดเตียง	8 คน
หญิง	2057 คน	กลุ่มดูแลระยะยาว (LTC)	9 คน
เด็กแรกเกิด – น้อยกว่า 1 ปี	21 คน	โรงเรียน	1 แห่ง
กลุ่มอายุ 1 – น้อยกว่า 5 ปี	93 คน	นักเรียน	112 คน
กลุ่มอายุ 5 – น้อยกว่า 20 ปี	545 คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 แห่ง
หญิงวัยเจริญพันธุ์ 15-49 ปี	1,438 คน	คลินิกชุมชนอบอุ่น	1 แห่ง
กลุ่มอายุ 35-59 ปี	1,359 คน	ร้านขายยา	1 แห่ง
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ขึ้นไป	1,424 คน	ร้านขายของชำ	9 แห่ง
คนพิการ (สิทธิคนพิการ)	คน	อสม.	122 คน

ที่มา: รายงานสำรวจข้อมูลสุขภาพของประชากรในพื้นที่ ปี 2568

ลักษณะองค์กร



ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ:

ตาราง 4 แสดงข้อมูลบุคลากรสารสนเทศสุข

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
1	นางมัสลิน โรจนวิจิตร	หัวหน้าศูนย์บริการสารสนเทศสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2	นางณัฏฐา แก้วประเทศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3	นางสาวแพรวพลอย แก้วแกมเงิน	นักวิชาการสารสนเทศสุขชำนาญการ	สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
4	นางสาวสุนิรมณ์ พลเมฆ	นักวิชาการสารสนเทศสุข	สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
5	นางสาวกัญญิกา สังข์จันทร์	นักวิชาการสารสนเทศสุข	สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
6	นางสาวฉนิษฐารักษ์ อินนังแท่น	เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
7	นางสาววัชรินทร์ สมบูรณ์มา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
8	นางวัชรพร สมบูรณ์มา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	มัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา: ทะเบียนบุคลากร ศบส.บ้านกล้วยแพะ



รูปภาพ 4 แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารศบส.บ้านกล้วยแพะ

ลักษณะองค์กร



ตาราง 5 แสดงจำนวนและอัตราส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรเป้าหมาย

ประเภทวิชาชีพ	เป้าหมาย	จำนวน (คน)	อัตราส่วน
พยาบาลวิชาชีพ	1 : 2,500	2	1 : 2,296
นักวิชาการสาธารณสุข	1 : 1,250	3	1 : 1,531

จากตาราง 5 แสดงจำนวนและอัตราส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรเป้าหมาย ของประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่พบว่าจำนวนอัตราส่วนของพยาบาลวิชาชีพยังไม่เพียงพอตามอัตราส่วนเป้าหมาย

ข้อมูลด้านสาธารณสุขมูลฐาน :

ตาราง 6 แสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อเขตรับผิดชอบหลังคาเรือน

ลำดับ	ชื่อชุมชน	จำนวนหลังคาเรือน	จำนวนอสม.	อัตราส่วนรับผิดชอบ
1	บ้านกล้วยหลวง	706	57	1:12
2	บ้านกล้วยหลวงพัฒนา	100	10	1:10
3	บ้านกล้วยแพะ	565	49	1:11
4	บ้านประสบสุข	67	6	1:11

ที่มา: ทะเบียนอสม. ศบส.บ้านกล้วยแพะ

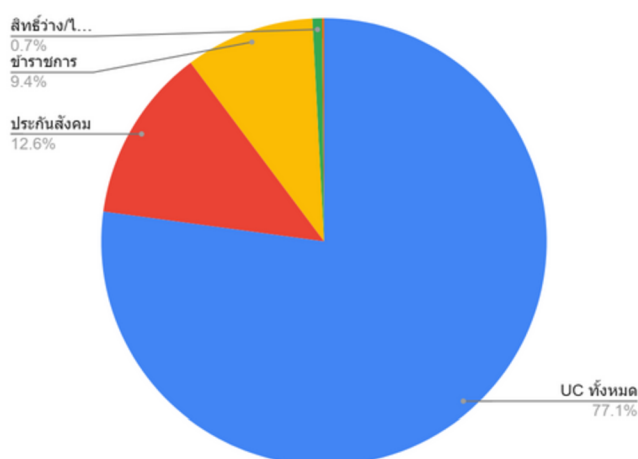
จากตาราง 6 แสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อเขตรับผิดชอบหลังคาเรือน มีจำนวนอสม.ทั้งหมด 122 คน โดยชุมชนที่มีจำนวนอสม.มากที่สุดคือ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน 57 คน ชุมชนที่มีอสม.น้อยที่สุดคือ ชุมชนบ้านประสบสุข จำนวน 6 คน หากเทียบอัตราส่วนจำนวนอสม.ต่อหลังคาเรือน พบว่าอสม. 1 คน ดูแล 10-12 ครัวเรือน

ลักษณะองค์กร



ตาราง 7 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพและแผนภูมิแสดงสัดส่วนตามสิทธิ ปี 2568

ประเภท	ปี 2568	
	จำนวน	ร้อยละ
UC ทั้งหมด	2655	67.71
ประกันสังคม	435	11.09
ข้าราชการ	323	8.24
สิทธิว่าง/ไม่ตรงรหัสมาตรฐาน	24	0.61
ต่างด้าว/ชำระเงินเอง	5	0.13
รวม	3,442	



ที่มา: รายงานความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ จาก JHCIS ณ วันที่ 15 ต.ค. 68

จากตาราง 5 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปี 2568 โดยคิดจากประชากรในทะเบียนฐานข้อมูล จากมากไปหาน้อย พบว่าปี 2568 สิทธิประเภท UC ทั้งหมด ร้อยละ 67.71 รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 11.09, สิทธิข้าราชการ ร้อยละ 8.24, สิทธิว่าง/ไม่ตรงรหัสมาตรฐาน ร้อยละ 0.61 และสิทธิต่างด้าว/ชำระเงินเอง ร้อยละ 0.13

ข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุข:

ลักษณะหน่วยบริการ ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น และฟื้นฟูสภาพ โดยให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลักษณะองค์กร



ตาราง 8 แสดงตารางให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ

วัน	เช้า (8.30-12.00)	บ่าย (13.00-16.30)
จันทร์	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิกเด็กดี (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, เยี่ยมบ้าน
อังคาร	ตรวจรักษาโรคทั่วไป	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิกจิตเวชทางไกล (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
พุธ	คลินิกโรคเรื้อรัง	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, วางแผนครอบครัว	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, วางแผนครอบครัว
ศุกร์	คลินิกโรคเรื้อรัง (พบแพทย์)	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, เยี่ยมบ้าน

ตาราง 9 แสดงจำนวนผู้มารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ ปี 2564 2568

ปีงบประมาณ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
ปี 2564	2,024	9,107
ปี 2565	1,962	6,147
ปี 2566	3,745	11,131
ปี 2567	3,212	11,340
ปี 2568	3,145	11,070

ที่มา: ฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านกล้วยแพะ ณ วันที่ 15 ต.ค. 68

จากตาราง 9 แสดงให้ทราบว่าศูนย์บริการฯ มีแนวโน้มจำนวนบริการเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึง การเป็นสถานบริการปฐมภูมิที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะในปี 2567 จำนวนครั้งในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนทิศทางการดำเนินงานที่เน้นการป้องกันก่อนการรักษา (Preventive & Promotive Health Services) แนวโน้มนี้สอดคล้องกับนโยบาย “สุขภาพดีเริ่มต้นที่ชุมชน” และการสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ



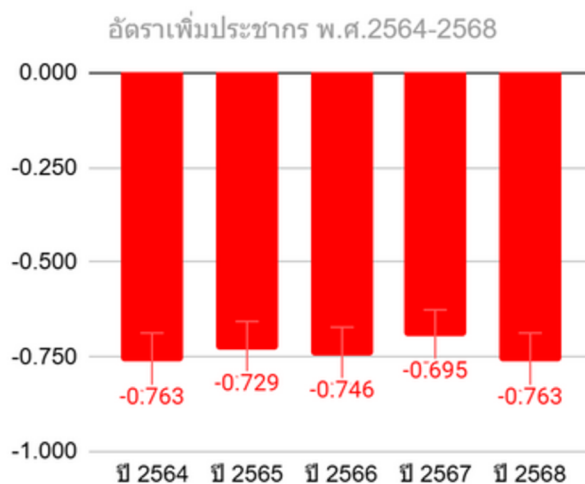
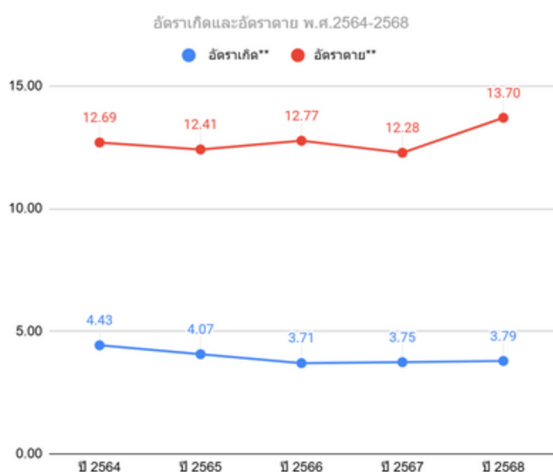
อัตราเกิด-ตายและร้อยละการเพิ่มประชากร:

ตาราง 10 แสดงจำนวนเกิด-ตาย ร้อยละการเพิ่มประชากรและประชากรกลางปี ปี พ.ศ.2564-2568

ปี พ.ศ.	จำนวนเกิด	จำนวนตาย	อัตราเกิด**	อัตราตาย**	อัตราเพิ่มประชากร***	ประชากร 1 ม.ค.
ปี 2564	22	63	4.43	12.69	-0.763	4,963
ปี 2565	20	61	4.07	12.41	-0.729	4,915
ปี 2566	18	62	3.71	12.77	-0.746	4,857
ปี 2567	18	59	3.75	12.28	-0.695	4,806
ปี 2568	18	65	3.79	13.70	-0.763	4,744

ที่มา: ฐานข้อมูลเกิด-ตาย(ปีที่เกิด-ตายตามทะเบียน) JHCIS ศบส.บ้านกล้วยแพะ ณ วันที่ 15 ต.ค.68

หมายเหตุ: หน่วยแสดง ** อัตราต่อพันประชากร *** อัตราร้อยละ



รูปภาพ 6 และ 7 แสดงกราฟอัตราการเกิด-ตาย และอัตราเพิ่มประชากร ปี 2564-2568

จากรูปภาพ 6 และ 7 แสดงอัตราเกิด-ตาย และกราฟแสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราเกิดและอัตราตายในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ พบว่าอัตราเกิดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2564 ถึง 2568 ส่วนปี 2568 พบว่าอัตราตายสูงสุดถึง 13.70% ซึ่งสูงกว่าอัตราเกิดมากกว่าสองเท่า สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่

สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ



มีภาวะการเกิดน้อยลงและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในส่วนของอัตราเพิ่มประชากร พ.ศ. 2564-2568 กราฟแสดงอัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นที่ที่มีค่าติดลบทุกปี สะท้อนให้เห็นภาพรวมว่าจำนวนประชากรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ตาราง 11 แสดงสาเหตุการตาย 10 ลำดับ ปีงบประมาณ 2566-2568 (อัตราต่อแสนประชากร)

ที่	สาเหตุการตาย	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	มะเร็งทุกชนิด	6	123.53	9	187.27	10	210.9
2	ภาวะสมองเสื่อม	9	185.30	9	187.27	8	168.63
3	หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	6	123.53	4	83.23	3	63.24
4	หลอดเลือดสมอง	0	0.00	4	83.23	2	42.16
5	ไตวายเรื้อรัง,เฉียบพลัน	3	61.77	1	20.81	2	42.16
6	โรคตับ	0	0.00	2	41.61	2	42.16
7	วัณโรค	1	20.59	1	20.81	1	21.08
8	ไข้เลือดออก	0	0.00	1	20.81	0	0.00
9	ฆ่าตัวตาย	0	0.00	0	0.00	1	21.08
10	ถุงลมโป่งพอง	0	0.00	0	0.00	2	21.08

ที่มา : รายงานการเสียชีวิต ฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านกล้วยแพะ ณ วันที่ 15 ต.ค.68

จากตารางที่ 11 แนวโน้มสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะในช่วงปีงบประมาณ 2566-2568 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ และโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ จึงควรมุ่งเน้นมาตรการส่งเสริมสุขภาพในการคัดกรองโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาว

สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ



ตาราง 12 แสดง 10 ลำดับโรคแยกตาม ICD10 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	โรค	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
1	ความดันโลหิตสูง	723	3281
2	เบาหวาน	515	2256
3	ไขมันในเลือดสูง	337	2076
4	ไข้หวัด	150	195
5	ผื่นคันตามร่างกาย	83	148
6	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	22	155
7	เวียนศีรษะ	62	92
8	ท้องผูก	43	107
9	ผิวหนังอักเสบ	41	214
10	อาหารไม่ย่อย	12	72

ที่มา: : รายงานจากฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านกล้วยแพะ ณ วันที่ 15 ต.ค.68

จากตารางที่ 12 แสดงข้อมูลสถิติผู้ป่วยนอกของศูนย์บริการสาธารณสุขสุขบ้านกล้วยแพะ ปีงบประมาณ 2568 พบว่า 3 อันดับโรคแรกที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง มีผู้มารับบริการจำนวน 723 คน รวม 3,281 ครั้ง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน มีผู้มารับบริการ 515 คน รวม 2,256 ครั้ง และไขมันในเลือดสูง มีผู้มารับบริการจำนวน 337 รวม 2,076 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพหลักของประชาชนในพื้นที่และจำเป็นต้องได้รับการติดตามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ยังพบโรคทั่วไปที่เกิดจากการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ไข้หวัด จำนวน 150 คน ผื่นคันตามร่างกาย จำนวน 83 คน, ปวดเมื่อยตามร่างกาย จำนวน 22 คน, เวียนศีรษะ จำนวน 62 คน, และท้องผูก จำนวน 43 คน ซึ่งมักเป็นโรคเฉียบพลันที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ สำหรับ ผื่นคันอักเสบ พบผู้มารับบริการจำนวน 41 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน ขณะเดียวกันยังพบปัญหาทางเดินอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ควบคู่กับโรคทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน

สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ



ตาราง 13 แสดงโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ 10 อันดับ ในปีงบประมาณ 2566-2568

ลำดับ	โรค	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	โรควัณโรค (Tuberculosis)	6	123.53	12	249.69	14	295.11
2	โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)	0	0.00	0	0.00	10	210.79
3	โรคเยื่อตาอักเสบ (Conjunctivitis)	2	41.18	3	62.42	4	84.32
4	โรคอีสุกอีใส (Chicken pox)	2	41.18	2	41.61	3	63.24
5	โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease)	2	41.18	2	41.61	3	63.24
6	โรคติดเชื้ออาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus)	0	0.00	0	0.00	2	42.16
7	โรคไขหูดับ (Streptococcus suis)	0	0.00	0	0.00	2	42.16
8	โรคฉี่หนู (Leptospirosis)	0	0.00	0	0.00	1	21.08
9	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	13	267.65	2	41.61	1	21.08
10	โรคไข้เลือดออก (Dengue fever; DF)	3	61.77	10	208.07	0	0.00

ที่มา: : ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคระบาด ข้อมูลถึง วันที่ 30 ก.ย.2568 (อัตราป่วย หน่วยต่อแสนประชากร)

จากตารางที่ 13 แสดงข้อมูล 10 อันดับโรคติดต่อที่สำคัญทางระบาดวิทยา ของศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านกล้วยแพะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า โรคที่มีการรายงานมากที่สุดคือ โรควัณโรค (Tuberculosis) จำนวน 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 295.11 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 210.79 ต่อแสนประชากร ในลำดับที่ 3 พบโรคเยื่อตาอักเสบ (Conjunctivitis) จำนวน 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 84.32 ต่อแสนประชากร ในลำดับที่ 4 พบโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) และโรคมือเท้าปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease) คิดเป็นอัตราป่วย 63.24 ซึ่งส่วนใหญ่พบการติดเชื้อในเด็ก โรคติดเชื้ออาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus) อยู่ในลำดับที่ 5 พบจำนวน 2 ราย เช่นเดียวกับโรคไขหูดับ (Streptococcus suis) คิดเป็นอัตราป่วย 42.16 ต่อแสนประชากร ส่วนโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบอัตราป่วย 21.08 มีแนวโน้มน้อยลง เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก (Dengue fever; DF) มีการระบาดลดลงในปี 2568 ซึ่งไม่พบจำนวนผู้ป่วย

สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ



ตาราง 14 แสดงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 10 อันดับ ในปีงบประมาณ 2568

ที่	โรค	ปี 2568	
		จำนวน	อัตรา
1	โรคความดันโลหิตสูง	723	15,240.30
2	โรคเบาหวาน	515	10,855.82
3	โรคไตเรื้อรัง	337	7,103.71
4	โรคหลอดเลือดสมอง	25	526.98
5	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	15	316.19
6	โรคมะเร็งเต้านม	8	168.63
7	โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่	4	84.32
8	โรคมะเร็งปากมดลูก	2	42.16
9	โรคหัวใจขาดเลือด	1	21.08
10	โรคหอบหืด	1	21.08

ที่มา: : รายงานจากฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านกล้วยแพะ ณ วันที่ 1 ต.ค.68

จากตารางที่ 14 แสดงข้อมูล จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านกล้วยแพะ ประจำปีงบประมาณ 2568 พบว่าโรคที่พบมากที่สุดในพื้นที่คือ โรคความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วย จำนวน 723 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15,240.30 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ โรคเบาหวาน จำนวน 515 ราย อัตราป่วย 10,855.82 ต่อแสนประชากร ซึ่งทั้งสองโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญและมักพบร่วมกัน ในกลุ่มประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โรคที่พบในลำดับต่อมา ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง จำนวน 337 ราย และ โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 25 ราย ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดตามมาจากการควบคุมระดับน้ำตาล และความดันโลหิตไม่ดีพอ นอกจากนี้ยังพบโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรรมการดำเนินชีวิต เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหอบหืด ซึ่งแม้จำนวนผู้ป่วยจะไม่มาก แต่เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง